

山口大学の地獄のICTを研究化する可否と実務設計

エグゼクティブサマリ

ご提示の「地獄のICT」を研究論文にすること自体は**十分可能**です。ただし、研究として成立するかどうかは「イベントの主催者が誰か」だけで決まるのではなく、**誰が研究責任者になるか、どの機関の研究者がデータ取得・解析・公表に関与するか、開催側が共同研究機関なのか研究協力機関なのか、あるいは単なる会場提供者なのか**で決まります。国の倫理指針では、人を対象として健康の保持増進や医療の改善に資する知識を得る活動は「人を対象とする生命科学・医学系研究」に当たり、複数機関で行うなら研究代表者・共同研究機関・研究協力機関の整理が必要です。逆に、単なる内部改善の満足度調査で一般化可能な知見の創出を目的にしないなら、同じアンケートでも研究ではなく業務評価として扱われる余地があります。 ①

結論を先に言うと、**山口大学の9月開催回は「探索的パイロット」には向くが、主論文化の本番会場としては時期とサンプル数の両面で厳しいです**。リポジトリ上の企画書では1セッションあたり12~40名、AI初心者向け、120分のチーム対抗型で、NotebookLM・GPT-4o・ハルシネーション罠・個人情報罠・デブリーフまで明確に設計されています。これは教育介入として非常に魅力的ですが、**単回・少人数・同一イベント内の自己申告中心**だと、強い因果推論や尺度妥当性検証には足りません。したがって、山口大回だけで狙うなら「教育実践報告」「パイロット研究」「短報」が現実的です。 ②

一方で、**代替案としてのICNJ九州支部イベントは、主研究の本命としてかなり有利です**。公開情報では、2025年度の九州・沖縄支部総会・地方会は116名定員・109名参加で、報告書では「次回の地方会は2026年10月31日」と案内されています。つまり、現時点の公開情報ベースでは「11月」より**2026年10月31日**が確認できる日付です。参加者規模と多施設性は、教育効果・実務転用・感染制御現場への一般化可能性を高めます。しかも、九州大学の観察研究倫理審査委員会は2026年9月28日開催分の提出期限が8月10日、10月19日開催分の提出期限が9月10日なので、**2026年7月29日現在では、ICNJ本番に合わせた九州大主機関ルートの方が現実的です**。 ③

したがって、最も堅い推奨は、**山口大学9月は「計測系を磨くパイロット」、ICNJ九州支部は「主論文化の本番」という二段構え**です。主たる研究機関は、ユーザーが九州大学医学教育学部共同研究員として研究主体になるのであれば、まずは**九州大学を主機関候補**に置き、開催側は役割に応じて研究協力機関または共同研究機関として整理するのが最も説明しやすいです。ただし、9月山口大回で研究として先行実施したい場合は、**山口大学側の正式な共同研究者・所属先・審査ルートを即決できるかがボトルネック**になります。 ④

比較表

以下の表は、国の倫理指針、九州大学・山口大学の公式手続ページ、山口大学感染制御部・ご提示リポジトリ・ICNJ公開情報を整理したものです。 ⑤

実施パターン	研究責任の置き方	倫理審査の考え方	2026-07-29時点の現実性	論文化向きか
山口大9月・九大主機関	あなたが研究代表、山口大側は共同研究機関または研究協力機関	九州大学観察研究倫理審査委員会が主。山口大側は役割に応じて一括審査参加または実施許可整理が必要	低～中 。九州大9月委員会の締切は8月10日、8月委員会締切は既に経過しており、9月イベントにはかなりタイト ⑥	パイロットなら可、本番主論文にはやや不利

実施パターン	研究責任の置き方	倫理審査の考え方	2026-07-29時点の現実性	論文化向きか
山口大9月・山口大病院主機関	山口大感染制御部側の教員・病院職員が研究責任者、あなたは共同研究者	山口大学医学部附属病院のREC/IRB系。毎月第4水曜開催が原則、2026年9月は9月30日、結果返却はIRB後1週間前後	中 。8月26日審査に間に合えば9月後半イベントは可能性あり。ただし書類完成度次第 ⁷	山口大回だけを論文化したい場合の現実ルート
山口大9月・山口大保健学系主機関	山口大保健学系の共同研究者が主責任者	保健学専攻の倫理審査日程。2026年9月分の申請締切は9月1日、8月申請分審査は9月	条件付きで中 。実際に誰の所属ルートで出すかが鍵 ⁸	教育研究としては組みやすい可能性
ICNJ九州・九大主機関	あなたが研究代表、ICNJ側は開催許可・募集協力	九州大学主審査。一括審査または他機関結果受領の運用が制度上明示	高い 。10月31日公開情報ベースなら十分準備可能 ⁹	最も論文化向き
ICNJ自体を主機関化	学会支部・一般社団法人側が研究機関になる	指針上、一般社団法人も研究機関たり得るが、実務上は独自倫理体制が必要になりやすい	低い 。避けた方がよい ¹⁰	非推奨

判断の急所は、開催側がどこまで研究に入るかです。国指針では、複数機関が一つの研究計画書で研究を実施するなら「共同研究機関」、新たな情報を集めて研究機関に提供するだけなら「研究協力機関」です。任意団体ではなく一般社団法人も研究機関になり得ますが、その場合は倫理体制まで問われるため、学会主催イベントでは**学会を研究主機関にしない方が通常は楽**です。 ¹⁰

倫理審査要件と必要書類の比較

以下は公開されている公式手続から見える、最低限そろえるべき書類群の比較です。 ¹¹

機関・ルート	公開されている主要書類	実務上ほぼ必須とみるべきもの
九州大学 観察研究	観察研究倫理審査申請書、実施体制一覧、同意説明文書、ホームページ公開用資料、利益相反報告、倫理審査料様式、提出前チェックシート、参考資料、実施許可申請書、一括審査用の倫理審査依頼書 ¹²	研究計画書、説明文書、アンケート票、解析計画、COI、実施体制、公開資料
山口大学 病院 REC/IRB 系	倫理審査申請システム、申請書式、業務手順書・SOP、同意説明文書雛形、開催日、教育研修要件 ¹³	研究計画書、説明文書、質問票、役割分担、COI、教育研修受講、必要に応じて他委員会審査依頼関連文書
山口大学 保健学系	倫理審査日程、チェックリスト、研究計画書様式、説明文書様式、同意書様式、利益相反関連様式 ¹⁴	研究計画書、説明文書、質問票、チェックリスト、COI、研究実施体制

機関・ルート	公開されている主要書類	実務上ほぼ必須とみるべきもの
学会主催イベント	学会側の研究専用書類は通常期待しにくい	開催側の 文書許可 、募集文面承認、会場内アナウンス方法、個人情報の流れの確認

想定スケジュール比較

ルート	公開スケジュール	この案件への含意
九州大学 観察研究	通常承認まで約2か月。2026年9月28日委員会の締切は8月10日、10月19日委員会の締切は9月10日 ¹⁵	9月山口大本番には厳しいが、10月31日のICNJ本番には十分間に合う
山口大学病院 REC/IRB系	原則毎月第4水曜開催、2026年9月は9月30日。新規臨床研究の書類締切は委員会開催日の2週間前、結果返却はIRB後1週間前後 ¹⁶	8月委員会に滑り込めれば、9月後半イベントは可能性あり
山口大学保健学系	2026年9月審査分の申請締切は9月1日、8月申請分審査は9月に実施 ¹⁷	教育研究型のルートとしては組めるが、実際の共同研究者所属が必要
ICNJ九州代替	公開報告では次回地方会は2026年10月31日。2025年度の会場は九州大学医学部百年講堂、定員116名・参加109名だった ¹⁸	サンプル確保と日程の両面で最も現実的

倫理と審査の判断基準

今回の案件で最初に切り分けるべきなのは、これは「**イベント改善のための回収**」なのか、「**一般化可能な知見を得て論文化する研究**」なのかという点です。国のガイダンスでは、人を対象に、健康の保持増進や医療の改善に資する知識を得る活動は倫理指針の対象になります。他方、定義に当たらない活動は直ちに同指針の対象ではありません。したがって、「次回の運営改善だけが目的」の満足度回収なら業務評価で済む余地がありますが、「AIを用いた感染制御研修は何を学習させ、どの程度行動変容の意図や実務転用を生むか」を一般化可能な問いとして論文化するなら、研究として扱うのが安全です。 ¹⁹

主催者が山口大学感染制御部であっても、**あなたが研究主体で解析・公表を主導するなら、九州大学を主機関にして山口大側を共同研究機関または研究協力機関に置く構成は理論上可能**です。国指針では「研究責任者」は所属研究機関で当該研究を統括する者、「研究代表者」は多機関共同研究で複数機関の研究責任者を代表する者と定義されています。また、開催側が新たに情報を取得して研究機関へ提供するだけなら研究協力機関、研究計画書に基づいて共同で研究を行うなら共同研究機関です。つまり、山口大側が**会場提供とQR提示**だけなら研究協力寄り、**質問票設計・データ閲覧・共著・解析参加まで**行うなら共同研究機関寄りで ²⁰

九州大学側の公開手続では、多機関共同研究について、**本学が主機関なら他機関も本学で一括審査できる一方、他機関が主機関なら九州大委員会への付議は不要で、審査結果通知と承認書類を受領して提出する運用**が明記されています。したがって、九州大主機関で進めるか、山口大主機関で進めるかを早めに決めることで、必要書類の束が大きく変わります。 ¹²

山口大学側については、病院の公開情報で、2023年4月から治験審査委員会と人医学研究等倫理審査委員会に再編され、病院REC/IRB系が稼働していることが確認できます。また、公開SOP断片では、**他の倫理審査委員**

会への審査依頼と契約の条項も見えており、外部委員会の審査結果を活用する余地があると読めます。ただし、これは実際には病院事務・規程運用に強く依存するため、形式上可能でも、9月案件で新規に動かすには負担が大きいです。 21

同意取得は、今回のような**侵襲なし・介入なしの質問紙やインタビュー**では比較的シンプルにできますが、重要な落とし穴があります。国ガイダンスでは、アンケート等で新たに情報を集める研究では「適切な同意」が可能で、チェック欄、メール返信、ボタンクリック等も許容されます。しかし、**アンケートを回収した事実だけでは適切な同意を得たことにならない**と明記されています。よって、QRコードで飛ばした最初の画面に、研究説明の要点と「**研究参加に同意して次へ進む**」の明示チェックを置くのが安全です。 22

逆に、オプトアウトは主に既存情報や、適切な同意取得が困難な場合の例外手続です。今回のようにイベント参加者からその場で新たに回答をもらう設計では、**オプトアウト一本で押し切るより、明示的同意または適切な同意を取る方が適切**です。 23

さらに今回は、企画書の設計自体に倫理上の論点があります。リポジトリでは、NotebookLMは参加者自身のGoogleアカウント利用、GPT-4oは運営側プロキシ経由、さらに**AIログをサーバに残してDebriefでリプレイ**する構想が示されています。研究でこのログを使う場合、質問票よりもセンシティブな「学習過程データ」になります。加えて、九州大学の観察研究サイトでは、外国にある者へ試料・情報提供がある場合、**提供先国、当該国の個人情報保護制度、保護措置**の記載を求めています。したがって、**研究の最初の論文ではAIログは使わず、質問紙のみを対象にした方が倫理申請は軽く、Google/海外提供論点も最小化しやすい**です。ログ解析は別研究に分けるのが賢明です。 24

最後に、参加の自由性です。ICNJの公開案内では、地方会を最後まで受講した参加者に修了証が出ます。修了証や研修ポイント、主催者との関係性があるイベントでは、**アンケート回答の有無が参加・修了・表彰・景品と無関係であることを**説明文と口頭アナウンスで明確に分離すべきです。研究者と参加者に上下関係や依存関係がある場合の配慮は、国ガイダンスでも重視されています。 25

論文化の可否評価

「地獄のICT」は、教育研究として見ると**かなり論文向きの素材**です。理由は三つあります。第一に、学習目標が単なるAI一般論ではなく、**要件言語化、データ整形、受け手別文書生成、ソース接地、ハルシネーション耐性、個人情報の境界判断**という、感染制御の実務に近いスキルに具体化されていること。第二に、成功体験と失敗体験を同じ介入内に組み込んでおり、特にStage 3とStage 4が教育工学上の“介入の核”として明確であること。第三に、デブリーフまで含めた一連の設計が、単なるイベント満足度ではなく、**なぜその学習が起こるのか**を説明しやすいことです。 26

一方で、**そのままでは強い原著論文には弱い**です。最大の理由はサンプルサイズです。企画書では1セッション12～40名なので、探索的記述や前後比較には使えても、尺度開発や因子分析、施設種別別の多変量解析には通常足りません。尺度開発や検証では、一般に**項目あたり約10名、または全体で200～300程度**が推奨され、SEM/CFAでも200前後が一つの目安として扱われます。したがって、山口大1回だけで独自尺度の妥当性まで示すのは無理があります。 27

また、バイアスも明確です。想定参加者はAI初心者を含む、感染制御に関心の高い職員群であり、参加自体に自己選択バイアスがあります。チーム対抗・発表・表彰の場では、社会的望ましさバイアスや高揚感による過大評価も起こりやすいです。実際、近年のAIワークショップ研究でも、単日イベントの自己申告前後比較では有意改善が出ても、**低回答率・追跡率の低さ・回想バイアス・社会的望ましさバイアス**が限界として報告されています。 28

したがって、山口大学9月回だけで狙うなら、最も現実的な論文化のかたちは、**探索的パイロット研究あるいは教育実践報告**です。例えば、「感染制御実務における生成AI研修ゲームの実施可能性と参加者の認知・行動

意図の変化」といった問いで、主要アウトカムを実施可能性・受容性・自己効力感変化に置けば成立します。国内でも、感染対策教育は、無記名の前後試験や理解度調査、満足度調査、手指衛生遵守率比較を用いて論文化されてきました。精神科病院の職員教育では前後の理解度得点が有意に改善し、アクティブ・ラーニングを取り入れた手指衛生研修でも高い満足度が示されています。さらに介護施設職員を対象としたARCSモデル活用手指衛生教育では、**知識得点だけでなく一部の遵守率改善**まで報告されています。 ²⁹

その意味で、**山口大回は「手法の筋がよいか」を確かめる場としては優秀**です。逆に、**ICNJ九州回は「より大きいNで、より外的妥当性の高い主論文」を狙う場**として優秀です。2025年度の九州・沖縄支部地方会は109名参加で、しかも対象が感染管理担当者や学生を含む広い実務者層でした。公開報告では次回の地方会は2026年10月31日とされていますから、時期と規模の両方でこちらが本命です。 ³⁰

要するに、**論文化の可否は「可」**ですが、**最適な論文タイプは会場により異なる**、というのが結論です。山口大9月ならパイロット、ICNJ九州なら準本番以上、という評価です。 ³¹

アンケート設計案

まず大前提として、今回の介入は「ただ面白かったか」を聞くだけでは弱いです。リポジトリの設計を見る限り、最低でも**反応、学習、実務への転用意図、感染制御上の安全認識**の四層を分けて測る方がよいです。さらに、単純な事前事後だけでなく、**当日終了時の retrospective pre-post**を使うと、学習前には自分の未熟さを正しく見積もれない問題に対応しやすいことが、近年のAIワークショップ研究でも使われています。ただしこの方式も回想バイアスを持つので、可能なら短い客観式知識問題を併用すべきです。 ³²

アンケート案の比較

以下の比較は、国内の感染対策教育研究、AIワークショップ評価研究、尺度開発のサンプルサイズ論、WHOのHHSAP/IPCAFの考え方を踏まえた実装向け提案です。 ³³

案	主目的	質問項目例	尺度	推奨サンプル数	主分析	倫理上の要点
探索的パイロット案	実施可能性・受容性・改良点の把握	「感染制御の実務に関連していた」「120分の負荷は適切だった」「AIの便利さと危うさの両方を体験できた」「同僚と議論しやすかった」「最も学びが大きかった場面はどこか（自由記述）」	5件法 リッ カー ト＋ 自由 記述	20～40 で十分。 山口大回 向き	記述統計、中央値比較、自由記述のテーマ分析	匿名で可。明示チェック同意を入れる。回答しなくても参加・表彰に影響しないことを明記 ³⁴
仮説検証案	学習効果の前後差検証	retrospective pre-postで「AIに渡す要件を言語化できる」「AI出力の根拠確認ができる」「個人情報を書き分けられる」＋知識問題8～10問	5件法 リッ カー ト＋ 客観 式	34以上の対応データで中等度効果を狙える。実務上は50～80を推奨	paired t検定またはWilcoxon、McNemar、効果量dz/r	同意は明示。無記名連結コードを使う。アンケート回収だけでは同意とみなさない設計にする ³⁵

案	主目的	質問項目例	尺度	推奨サンプル数	主分析	倫理上の要点
教育効果測定案	当日効果と1か月後の実務転用確認	当日：反応・自己効力感・知識。1か月後：「実際にAIで通知文／資料作成をした」「根拠確認を行った」「職場で再利用したプロンプトがある」「AI利用時に個人情報を外した」	当日5件法、追跡は頻度尺度	本番は80～120が望ましい。ICNJ向き	反復測定、GEEまたは混合効果モデル、追跡率分析	フォローアップ連絡先は別フォームで回収し、本体データと分離保存 36
感染制御実践評価案	施設レベルのIPC成熟度との関連を見る	HHSAF/IPCAFを短縮した施設質問：「手指衛生監査・フィードバック」「標準予防策マニュアル」「教育実施体制」「アウトブレイク時の文書整備」など	項目得点化または施設層別	施設単位で最低30～50施設、できれば1施設1回答	施設属性別比較、相関、探索的回帰	個人ではなく施設回答になるため、個人匿名と施設特定性の両方に配慮 37

各案の実装イメージ

探索的パイロット案は、山口大9月回に最も合っています。企画書の「Debriefで笑っているか」「1か月後に過半が業務でAIを使ったか」という成功定義とも整合します。質問数は10～15項目程度に抑え、自由記述を2～3問置くのがちょうどよいです。論文は「実施可能性」「受容性」「教育設計の妥当性」を中心とした短報向きです。³⁸

仮説検証案では、主要仮説を明確にします。たとえば「研修後、AI活用自己効力感と安全な利用判断能力は上昇する」「ソース接地の必要性理解は上昇する」といった形です。Stage 3とStage 4があるので、客観式知識問題も作りやすく、単なる満足度研究から一段上に上げられます。国内の感染対策教育研究でも、前後の理解度得点比較は古典的で通りやすい設計です。³⁹

教育効果測定案は、主論文文化に最も向いています。AICCワークショップ研究でも、当日だけでなく約9か月後フォローアップを入れていましたが、追跡率の低さが弱点でした。今回なら、1か月後に絞り、しかも「プロンプトの再利用」「根拠確認」「匿名化して入力した経験」など、イベント設計に直結する行動項目を置く方が実用的です。²⁸

感染制御実践評価案は魅力はありますが、第一報の主目的にはしない方がよいです。HHSAFやIPCAFは本来施設レベルの系統的評価ツールなので、イベント参加者の個人回答で簡略化しすぎると解釈がぶれます。これをやるなら、ICNJのように多施設参加が見込める会場で、しかも「各施設1代表回答」に近づけた設計が必要です。³⁷

共通で入れるべき質問項目の推奨セット

最終的にどの案でも、**共通コア項目**を持っておくと比較しやすくなります。具体的には、参加者属性として職種、役職、感染制御業務年数、生成AI使用経験、NotebookLM等の利用経験、施設種別。主要評価として、①実務関連性、②自己効力感、③安全な利用判断、④ソース確認習慣、⑤転用意図。可能なら知識問題として、**ハルシネーション対応、個人情報入力、ソース接地の使い分け**の3領域から各2～3問を入れるのがよいです。これは企画書の学習目標とも一致しています。⁴⁰

匿名化と同意取得の具体案

匿名性を守りながら前後比較するなら、**氏名やメールを本票に入れない**のが基本です。最も扱いやすいのは、参加時にランダム配布する**研究用IDカード**を使い、前後アンケートで同じIDだけ入れてもらう方式です。参加者自身に規則でコードを作らせる方式は、再識別性や入力ミスが起きやすいので、今回はあまり勧めません。フォローアップが必要な場合だけ、メールアドレスは**別フォーム**で回収し、本票とは別保存にします。これにより、本票は実質匿名、追跡名簿は連絡専用という分離ができます。 ⁴¹

同意は、紙でもWebでもよいですが、Webなら最初のページに研究説明の要点、問い合わせ先、自由参加、撤回方法、データ利用目的、保存期間、共同研究機関の有無を示し、「**研究参加に同意する**」に**チェックしないと進めない設計**にします。オプトアウトではなく適切な同意を取る、ということです。 ²²

データ保管期間と管理方法

保管期間は、**所属機関SOPと投稿先規程を優先**して研究計画書に明記するのが原則です。そのうえで実務案としては、**研究終了または論文公表後5年**を一つの標準にし、個票データ、本解析ファイル、同意関連文書、版管理済み質問票を分けて保存するのが扱いやすいです。共同研究や試料・情報提供では、指針ガイダンス上、提供記録の保存も要求されます。保存場所は、九州大主機関なら九州大管理領域、山口大主機関なら山口大管理領域に寄せるのが自然です。外部クラウド利用時は、識別情報を入れないか、入れるなら国外提供説明を追加すべきです。 ⁴²

実施場所別の比較

山口大学九月開催の利点と欠点

山口大学回の最大の利点は、**介入の純度**です。リポジトリの企画書どおりに、AI初心者を対象に、3～4人1組、1台PC、120分、罝からの復旧までを一貫して回せるなら、教育介入としての再現性が高くなります。さらに、山口大学感染制御部は日常的に感染対策の評価・指導・教育を担っているので、感染制御実務との継続性を説明しやすいです。 ⁴³

しかし欠点もはっきりしています。第一に、**少人数**です。1セッション12～40名では、群間比較や尺度検証には不足しやすい。第二に、**時間**です。2026年7月29日現在、九州大主機関ルートで9月イベント前に承認を得るにはかなり厳しく、山口大側ルートでも、どの委員会に出すかを即断しないと間に合いません。第三に、開催側と研究側が近すぎると、参加者が「答えないと悪い」と感じやすく、満足度が上振れしやすいことです。 ⁴⁴

ICNJ九州支部イベントの利点と欠点

ICNJ九州支部イベントの利点は、**Nと外的妥当性**です。2025年度の地方会は116名定員・109名参加で、参加者は会員・非会員・学生を含む広い層でした。しかもテーマ自体が手指衛生や行動変容など感染制御実務に寄っているため、教育介入の評価対象として自然です。今回のAI研修をここに載せられれば、「**特定施設の内輪の実践**」から「**多施設の感染管理実務者への教育効果**」へ昇格しやすいです。 ³⁰

時間面でも有利です。公開報告では次回の地方会は2026年10月31日とされており、これは2026年7月29日から見て、九州大学の9月28日委員会または10月19日委員会に間に合わせる現実的余裕があります。特に主研究機関を九州大学にするなら、**このタイムウィンドウは大きな利点**です。 ⁴⁵

欠点は、イベントの統制が山口大回より弱いことです。対象者が多様で、会場運営も学会・支部の都合に左右されます。教育経験の均質性、PC環境、時間配分、募集文面、修了証との分離、学会側の許可文書など、

実務的な取り決めが増えます。とはいえ、**研究としてはむしろこの複雑さを管理できる方が価値になる**とも言えます。 46

推奨最終案と実行フロー

私の推奨は、**二段階設計**です。すなわち、**山口大学9月回はパイロット、ICNJ九州支部回を主論文の本番**にする案です。これが、倫理・日程・サンプル数・論文化可能性のバランスが最もよいです。 47

具体的には、研究責任体制は次のように置くのが無理がありません。**研究代表者はあなた。主たる研究機関候補**は九州大学。**山口大回**では山口大学感染制御部側の共同研究者を1名以上入れ、9月回は質問票の理解度・実施可能性の確認に使う。**ICNJ回**ではICNJ九州支部は開催許可と募集協力を行う研究協力機関相当、あるいは必要に応じて共同研究機関相当として整理し、主データセットはICNJ回で収集する。こうすると、研究目的と実務の流れが最も説明しやすくなります。 48

推奨する最終デザイン

主論文のデザインは、**単群準実験研究**がよいです。アウトカムは、当日終了時の retrospective pre-post による自己効力感変化、客観式知識問題、満足度、1か月後の実務転用。主仮説は「研修後、AI活用自己効力感と安全な使用判断の自己評価は上昇する」「1か月後に一定割合が業務で再利用する」です。これなら、Yamaguchiでの小規模試行→ICNJでの本番→論文化という流れが自然に組めます。 49

実行ステップ

1. 今週中に研究の主機関を決める。

9月山口大回を九州大学主機関でいきなり本番研究にするのか、山口大側PIを立てて先行パイロットにするのか、あるいは山口大回を純粋パイロットにしてICNJ回を主研究にするのかをまず決めます。公開スケジュール上、この判断が遅れると9月案件は厳しくなります。 50

2. 開催側の役割を文書化する。

山口大感染制御部、ICNJ九州支部それぞれについて、募集周知だけか、当日配布だけか、個票アクセスがあるか、共著者になるかを整理します。ここで共同研究機関か研究協力機関かの線引きを固定します。 50

3. 山口大回の質問票は“パイロット仕様”に絞る。

10～15項目の短い質問票にして、同意画面、属性、自己効力感4～6項目、満足度4項目、自由記述2項目程度に抑えます。山口大回で設問の理解不能項目や天井効果を洗い出します。 51

4. ICNJ本番用には客観式問題と1か月追跡票を追加する。

8～10問の客観式知識問題と、1か月後の実務転用票を追加し、主論文の解析計画を事前に固定します。 52

5. AIログは初回論文では使わない。

企画書にはサーバログの保存・Debriefリプレイ構想がありますが、初回論文では質問票と客観式問題だけで十分です。ログ解析は別研究に分けた方が倫理上も審査上も軽くなります。 53

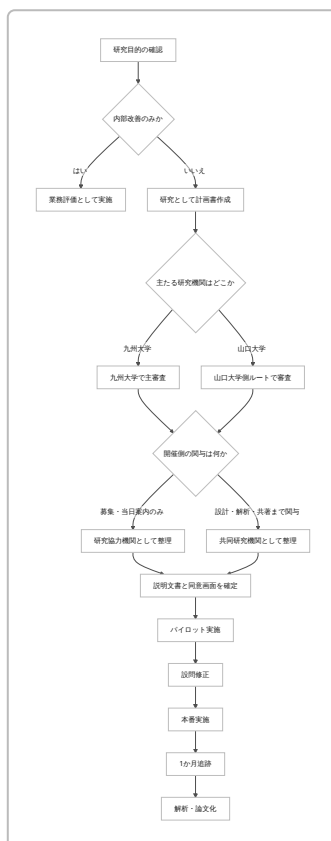
6. 同意と参加特典を完全分離する。

参加・表彰・修了証・景品と、研究アンケートの回答有無を独立させます。案内文、司会口頭説明、Web同意画面の三層で同じことを言います。 54

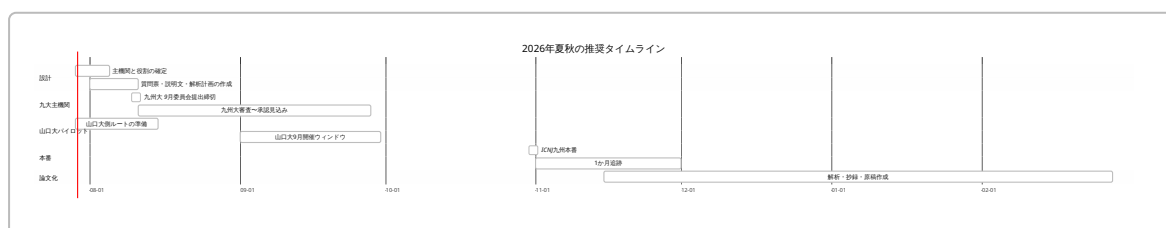
7. 九州大学本番審査に間に合う日程で提出する。

ICNJ回を主研究にするなら、まずは2026年8月10日の九州大提出締切を第一目標にし、無理でも9月10日締切・10月19日委員会ルートを次善案にします。 6

手続きフロー



想定タイムライン



このタイムラインの要点は、2026年7月29日現在、9月山口大回を九州大学主機関で本番研究にするより、10月31日のICNJ回を本番にする方が圧倒的に現実的という一点です。山口大回を捨てる必要はなく、むしろ良いパイロット会場として積極的に使うべきです。 55

類似研究と主要出典

今回の設計を支えるうえで、特に参考になる国内外の研究・公式資料は次のとおりです。以下は、単なる一般論ではなく、今回の質問票設計・分析・倫理整理に直接効くものを選んでいきます。 56

資料・研究	何が参考になるか
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス	研究の定義、共同研究機関・研究協力機関の整理、同意手続、オプトアウト、電磁的同意の扱いの基準になる 57
九州大学 観察研究倫理審査委員会 ページ	実際に必要な書類束、承認まで約2か月、一括審査の考え方、2026年度の締切日が明確 15
山口大学病院 REC/IRB系公開情報	9月委員会日程、結果返却目安、教育研修要件、病院側ルートの実現性判断に使える 58
山口大学保健学系倫理審査日程	9月案件を山口大教育研究系で出す場合の補助線になる 8
日本環境感染学会教育ツールを活用した職員教育	無記名前後試験で教育効果を示した国内の感染対策教育研究の先例。今回の前後比較設計に近い 59
Active Learningを手指衛生教育に取り入れた1事例	参加型感染対策研修でも満足度・実施可能性を論文化できることを示す国内例 60
ARCSモデルを用いた高齢者介護施設職員への手指衛生教育	知識得点だけでなく、一部行動指標まで比較した国内の教育効果研究として有用 61
AI for Clinical Care Workshop 研究	1日型AIワークショップでも論文化可能であること、retrospective pre-post の使い方、ただし低追跡率が弱点になることを示す近い先例 28
WHO HHSAP / IPCAF	感染制御実践評価を施設レベルで測るときの公的フレームワーク。副次目的の設計に使える 37
Boatengらの尺度開発ガイド	質問票項目数と必要サンプル数のバランスを考える基礎になる 62

最終的に一文でまとめると、9月の山口大学「地獄のICT」は“研究化してはいけない”ではなく、“主論文化の本番としては急ぎすぎるので、賢くパイロット化した方がよい”という評価です。そして、本命の論文は、九州大学主機関・ICNJ九州支部本番・明示的同意・匿名連結前後比較+1か月追跡で組むのが、現時点では最も成功確率が高いです。 63

1 5 10 19 20 22 23 34 35 41 42 48 54 56 57 <https://www.mhlw.go.jp/content/000769923.pdf>
<https://www.mhlw.go.jp/content/000769923.pdf>

2 24 26 31 32 38 40 43 53 <https://github.com/yukihiroyamaguchi569/hell-ict/blob/main/docs/%E4%BC%81%E7%94%BB%E6%9B%B8.md>
<https://github.com/yukihiroyamaguchi569/hell-ict/blob/main/docs/%E4%BC%81%E7%94%BB%E6%9B%B8.md>

3 18 45 https://icnj.jp/wp-content/uploads/hokoku_kyusyu-okinawa_2025.pdf
https://icnj.jp/wp-content/uploads/hokoku_kyusyu-okinawa_2025.pdf

4 <https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/research/ethics/medical/>
<https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/research/ethics/medical/>

6 44 47 50 55 63 <https://bioethics.kyushu-u.ac.jp/research/irb3/kaisaiyotei-irb3/>
<https://bioethics.kyushu-u.ac.jp/research/irb3/kaisaiyotei-irb3/>

7 16 58 <https://ccr.hosp.yamaguchi-u.ac.jp/schedule-irb/>
<https://ccr.hosp.yamaguchi-u.ac.jp/schedule-irb/>

- 8 17 https://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~soumu/syomu/hoken_iden_yousiki/r8pdf/r8schedule.pdf
https://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~soumu/syomu/hoken_iden_yousiki/r8pdf/r8schedule.pdf
- 9 11 12 15 <https://bioethics.kyushu-u.ac.jp/research/irb3/sinseisyo-irb3/>
<https://bioethics.kyushu-u.ac.jp/research/irb3/sinseisyo-irb3/>
- 13 <https://ccr.hosp.yamaguchi-u.ac.jp/law-system/>
<https://ccr.hosp.yamaguchi-u.ac.jp/law-system/>
- 14 https://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~soumu/syomu/hoken_iden_yousiki.htm
https://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~soumu/syomu/hoken_iden_yousiki.htm
- 21 <https://ccr.hosp.yamaguchi-u.ac.jp/about-rib/>
<https://ccr.hosp.yamaguchi-u.ac.jp/about-rib/>
- 25 30 46 <https://www.kuba.co.jp/icnjkyusyu-okinawa/>
<https://www.kuba.co.jp/icnjkyusyu-okinawa/>
- 27 51 62 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6004510/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6004510/>
- 28 36 49 52 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12695489/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12695489/>
- 29 33 39 59 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsei/23/5/23_5_371/_pdf/-char/ja
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsei/23/5/23_5_371/_pdf/-char/ja
- 37 <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HIS-SDS-2018.9>
<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HIS-SDS-2018.9>
- 60 <https://www.kankyokansen.org/journal/full/03704/037040148.pdf>
<https://www.kankyokansen.org/journal/full/03704/037040148.pdf>
- 61 https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsei/40/3/_contents/-char/ja
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsei/40/3/_contents/-char/ja